Клинические рекомендации

Воспалительные заболевания челюстей у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K10.2** — Воспалительные заболевания челюстей **M86** — Остеомиелит
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/997_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определения 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита 3

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области 4

3.4 Биопсия 4

3.5 Анализы крови и посев 5

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области 5

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи 5

4. Лечение 5

4.1 Антибактериальная терапия 5

4.2 Другая консервативная терапия 6

4.3 Хирургическое лечение 6

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

5.1 Показания к госпитализации 7

5.2 Профилактика и реабилитация 7

6. Источник и актуальность 7

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Хронический остеомиелит челюсти — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление кости более 4 недель с образованием секвестров или без тенденции к выздоровлению. Различают первично-хронический (негнойный), вторично-хронический (гнойный) остеомиелит и продуктивный периостит.
- При остеомиелите верхней челюсти, осложнённом верхнечелюстным синуситом или секвестрацией стенок пазухи, секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).
- Первично-хронический остеомиелит диагностируют по 2 большим или 1 большому и 3 малым критериям; для исключения сарком и фиброзно-костных поражений показана биопсия.
- Вторично-хронический остеомиелит лечат хирургически: секвестрэктомия или резекция челюсти после формирования и полного отграничения секвестра; антибиотики — по результатам посева.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Остеомиелит — воспалительное состояние костной ткани различной природы, которое начинается с медуллярной полости, быстро распространяется по системе гаверсовых каналов, вовлекая в воспаление надкостницу и прилегающие мягкие ткани.

Периостит — воспалительное заболевание, вовлекающее надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из одонтогенного или неодонтогенного очага.

Секвестр — отграниченный воспалительно-некротический очаг костной ткани, располагающийся более или менее свободно и не подвергающийся аутолизу.

Зубоальвеолярный сегмент — условная единица объёма альвеолярной части челюсти для оценки распространённости воспаления; верхняя граница сегментов верхней челюсти — дно полости носа и верхнечелюстных пазух.

Симптом Венсана — снижение чувствительности кожи над поражённым участком и (или) нижней губы.

1. **первично-хронический остеомиелит (негнойный)** — фиброзно-костное продуктивное заболевание без выявленного триггера: без гноя, свищей и секвестров, с упорно-рецидивирующим течением и избыточным образованием кости
2. **вторично-хронический остеомиелит** — гнойное деструктивное или пролиферативное воспаление более 4 недель, связанное с одонтогенной инфекцией, инородными телами, травмой, пороком развития кости или системными заболеваниями
3. **хронический периостит челюсти** — хронический одонтогенный процесс с надкостницей, который может выходить за пределы пародонта одного зубоальвеолярного сегмента
4. **хронический рецидивирующий мультифокальный остеомиелит** — неинфекционное многоочаговое литическое поражение костей; у взрослых — синдром SAPHO (синовит, акне, пустулёз, гиперостоз, остеит)

2.2 Этиология и эпидемиология

Первично-хронический остеомиелит — небактериальное воспаление неизвестной этиологии, связанное с аутоиммунными заболеваниями; преобладает генетическая теория, посевы, как правило, стерильны. Вторично-хронический связан с одонтогенной инфекцией, травмой, инородными телами; 65–75% флоры — неспорообразующие анаэробы. Продуктивный периостит чаще осложняет хронический периодонтит (74,6%) в области первого моляра.

Хронические негнойные формы встречаются с частотой 1–2 на 1 000 000; первично-хронический остеомиелит у девочек в 4 раза чаще, средний возраст 9–10,8 года. Продуктивный периостит чаще у мальчиков, дебют в 8,8–11 лет. Чаще поражается нижняя челюсть.

2.3 Классификация

1. **по течению** — первично-хронический (ювенильный продуктивный; синдром-ассоциированный — SAPHO, синдром Маджида, DIRA, PAPA); вторично-хронический (одонтогенный; неодонтогенный — неонатальный, травматический, от инородного тела, при мальформации сосудов); продуктивный периостит (простой, оссифицирующий — остеомиелит Гарре, посттравматический)
2. **по этиологии** — гнойный (специфический — туберкулёзный, актиномикозный; неспецифический — бактериальный, грибковый); негнойный (остеорадионекроз, медикаментозный, аутоиммунный)
3. **по локализации** — верхняя или нижняя челюсть; локальный (зубоальвеолярный сегмент, альвеолярная часть, базис, ветвь) или распространённый (тотальный, субтотальный)

Острый остеомиелит отличается от хронического длительностью **менее 4 недель** от появления симптомов.

2.4 Клиническая картина

Первично-хронический остеомиелит течёт с обострениями (от нескольких дней до недель) и ремиссиями (месяцы — годы); при поражении челюсти чаще у девочек, единичный очаг, дебют около 10 лет (4–14 лет).

Симптомы при поражении нижней челюсти

1. боль, часто усиливающаяся ночью, с лихорадкой или без;
2. ограничение открывания рта, отёк;
3. регионарная лимфаденопатия;
4. парестезия над очагом и (или) нижней губы.

Гноя, свищей и секвестров нет — это отличает его от острого и вторично-хронического остеомиелита. При тяжёлом течении исключают злокачественные новообразования, прежде всего острый лимфобластный лейкоз.

Около 25% пациентов имеют кожные (псориаз, ладонно-подошвенный пустулёз, акне) и кишечные заболевания (болезнь Крона, язвенный колит); при поражении челюсти, ключицы, грудины возможны бессимптомные очаги в скелете.

Вторично-хронический остеомиелит характеризуется гноем, свищами и секвестрами, течёт с обострениями.

Местные проявления

1. свищевые ходы до кости с гноем или грануляциями;
2. абсцессы и флегмоны при обострении;
3. ограничение открывания рта при поражении угла и ветви нижней челюсти;
4. подвижность зубов в очаге.

Продуктивный периостит — одностороннее безболезненное плотное утолщение задних двух третей нижней челюсти с умеренной асимметрией лица, без признаков воспаления кожи и слизистой; толщина нароста до 2–3 см. Иногда возможны свищ и лимфаденопатия.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Критерии диагноза первично-хронического остеомиелита

Большие критерии	Малые критерии
рентгенологически подтверждённые остеолитические и остеосклеротические очаги	хорошее общее состояние и нормальная лейкоцитарная формула
множественные очаги поражения	СОЭ и С-реактивный белок незначительно повышены
псориаз или ладонно-подошвенный пустулёз	длительность заболевания более 6 месяцев
стерильная биопсия с признаками воспаления и (или) фиброза, склероза	гиперостоз
—	связь с другими аутоиммунными заболеваниями; аутоиммунные и аутовоспалительные заболевания у родственников I и II линии

Для постановки диагноза необходимы 2 больших или 1 большой и 3 малых критерия.

3.2 Жалобы и анамнез

Сбор жалоб и анамнеза проводит челюстно-лицевой хирург или стоматолог-хирург.

Основные жалобы

1. боль в зубе или челюсти, иррадиация по ветвям тройничного нерва;
2. подвижность зубов, отёк мягких тканей;
3. парестезия нижней губы и подбородка;
4. ограничение открывания рта, боль при глотании, жевании, движениях языка;
5. свищи, деформация челюстей;
6. симптомы интоксикации.

Уточняют связь с заболеванием или удалением зуба, переохлаждением, простудой, перенапряжением; динамику и проведённое лечение.

3.3 Осмотр полости рта и челюстно-лицевой области

Оценка общего состояния: визуальный осмотр, термометрия, пальпация костной системы, осмотр полости рта и челюстно-лицевой области при обострении.

Клиническая оценка мягких тканей, регионарных лимфоузлов и полости рта: пальпация, перкуссия, степень открывания рта и подвижности нижней челюсти. Определяется изменение конфигурации лица за счёт инфильтрации и периостального утолщения; кожа над утолщением не изменена.

3.4 Биопсия

Биопсия из очага — для дифференциальной диагностики с фиброзно-костными поражениями и остеосаркомами: на ранних этапах их клиника сходна с хроническим остеомиелитом.

Патологоанатомическое исследование материала, полученного при операции, — дифференциальная диагностика с невоспалительными поражениями и специфическим воспалением.

3.5 Анализы крови и посев

Общий анализ крови — оценка выраженности воспаления. При обострении вторично-хронического остеомиелита — лейкоцитоз более $10 \cdot 10^9$/л, нейтрофилы до 70–80%; СОЭ до 40 мм/ч при гиперергии или в норме при гипоергии.

С-реактивный белок — динамика воспаления и необходимость коррекции терапии; при хронических формах повышение умеренное и неспецифичное.

Всем с подозрением на воспалительное заболевание челюсти — посев гноя, отделяемого свищей и ран с определением чувствительности; материал биопсии и вскрытия абсцесса обязательно направляют на посев.

3.6 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

КТ — для определения распространённости и типа процесса и планирования лечения, в том числе при обострении.

1. **первично-хронический** — на ранней стадии изменений может не быть; позже — смешанная картина склероза и остеолиза, периостальная реакция, «кость на кости»; секвестры крайне редки
2. **вторично-хронический** — очаги деструкции с секвестрами и участками остеосклероза; секвестр отграничивается **на 4–6-й неделе** на верхней челюсти и **на 6–8-й неделе** на нижней
3. **продуктивный периостит** — слоистые периостальные наслоения по типу «луковой шелухи» над компактной костью в области причинного зуба

3.7 УЗИ мягких тканей и лимфоузлов шеи

УЗИ мягких тканей, костей челюстно-лицевой области и лимфоузлов шеи — оценка гнойного процесса, дифференциальная диагностика с абсцессами, артритами и опухолями.

---

4. Лечение

Основные компоненты лечения

1. хирургическое лечение: санация очага, удаление причинного зуба, вскрытие и дренирование абсцесса;
2. противомикробная терапия — общая и местная;
3. патогенетическое и симптоматическое лечение.

1. **первая линия при первично-хроническом остеомиелите** — санация полости рта, НПВП
2. **вторая линия** — плоскостная резекция очага; антибиотики; системные глюкокортикоиды, бисфосфонаты, ингибиторы ФНО-альфа или интерлейкинов

4.1 Антибактериальная терапия

При выявлении инфекционной причины — рациональная антибактериальная терапия по результатам посева; шаблонное применение недопустимо. При первично-хроническом остеомиелите антибиотики неэффективны.

При обострении вторично-хронического остеомиелита антибиотик широкого спектра начинают эмпирически с первых часов в стационаре, эффект оценивают **через 2–3 дня**, затем корректируют по посеву. Типичная длительность — **5–10 дней**.

Критерии достаточности антибактериальной терапии

1. стойкая нормализация температуры;
2. положительная динамика основных симптомов;
3. нет признаков системной воспалительной реакции;
4. нормализация лейкоцитов, формулы, СОЭ, СРБ;
5. отрицательная гемокультура;
6. нормализация функции ЖКТ.

Нет ответа на адекватную терапию **за 1–3 дня** — дополнительное обследование (УЗИ, КТ, посевы) для поиска осложнений и вторичного очага.

При отягощённом соматическом статусе продолжительность увеличивают; при S. aureus или P. aeruginosa с бактериемией — **не менее 14 суток**.

4.2 Другая консервативная терапия

При обострении — дезинтоксикационная инфузионная терапия сбалансированными растворами.

Гипербарическая оксигенация — только как вспомогательный метод: высокая частота рецидивов и опасные осложнения.

При хроническом небактериальном остеомиелите — НПВП для купирования боли (эффективны у 40–80% детей): #метамизол натрия, парацетамол, ибупрофен, #кетопрофен.

При первично-хроническом остеомиелите — системные глюкокортикоиды после неудачи НПВП, при рецидивирующем или тяжёлом течении.

1. преднизолон — 2 мг/кг в сутки внутрь **1 неделю** с последующим снижением дозы на 25% каждые 5 дней.

Для стойкой ремиссии хронического остеомиелита — препараты, влияющие на минерализацию кости (бисфосфонаты).

1. #памидроновая кислота — 1 мг/кг (максимум 60 мг) ежемесячно или 1 мг/кг 3 дня подряд каждые 3 месяца.

4.3 Хирургическое лечение

Принципы хирургического лечения

1. вскрытие гнойного очага и удаление причинного зуба;
2. выбор обезболивания совместно с анестезиологом;
3. кратчайший доступ к очагу с наименьшим риском повреждения сосудов и нервов и лучшим оттоком.

При первично-хроническом остеомиелите — биопсия кости в объёме декортикации очага: улучшает доступ препаратов в очаг.

При продуктивном периостите — устранение источника инфекции (удаление или лечение зуба, вскрытие абсцесса) или травмы; иссечение изменённой надкостницы и избыточной кости.

При обострении — вскрытие поднадкостничного абсцесса внутриротовым доступом (периостотомия); при флегмоне или свище — вскрытие и дренирование наружным доступом.

При вторично-хроническом остеомиелите — секвестрэктомия или резекция челюсти в пределах неизменённой кости; проводится только после формирования секвестральной полости и полного отграничения секвестра.

На верхней челюсти используют внутриротовой доступ. При осложнении верхнечелюстным синуситом или секвестрации стенок пазухи секвестрэктомию выполняют по типу радикальной операции на верхнечелюстной пазухе (по Колдуэллу — Люку).

Дренирование гнойного очага (дренаж Пенроуза, силиконовые дренажи) и местное лечение раны по фазам: в I фазе — антисептики (хлоргексидин, #повидон-йод), во II — средства, стимулирующие репарацию.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация

1. обострение при суб- или декомпенсированных сопутствующих заболеваниях, гиперергическом течении, опухолях, иммунодефиците;
2. невозможность операции под местной анестезией (поведение ребёнка, сопутствующая патология, аллергия на анестетики);
3. отсутствие стоматолога-хирурга.

Плановая госпитализация

1. хронический остеомиелит со сформированным секвестром;
2. затяжное, торпидное или прогрессирующее течение с длительным формированием секвестров.

Выписка — при неосложнённом раннем послеоперационном периоде, удовлетворительном состоянии, контролируемой боли и возможности продолжить антибиотики амбулаторно под наблюдением челюстно-лицевого хирурга.

5.2 Профилактика и реабилитация

Основа профилактики — санация полости рта. Стоматолог-терапевт и стоматолог-хирург — не реже 1 раза в год, профессиональная гигиена — не реже 1 раза в 6 месяцев; при осложнённом кариесе — своевременное эндодонтическое лечение.

Физиотерапия (электрофорез, ультразвук, парафин) — после адекватного хирургического лечения; ЛФК в ремиссии.

Факторы риска рецидива

1. возраст **6–12 лет** (смешанный прикус);
2. лейкоцитоз более $15 \cdot 10^9$/л и температура выше 39 °C при поступлении;
3. MRSA-инфекция (риск выше в 4 раза);
4. предшествующее введение антибиотиков;
5. диабет.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Воспалительные заболевания челюстей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2028 года
Код в рубрикаторе	997_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.